

WALK-TEC-01_Entrevista — Entrevista

- Código de participante: TEC-01
- Perfil: Fisioterapeuta / usuario técnico
- Tipo de evidencia: Entrevista semiestructurada
- Fecha: No consignada en la transcripción suministrada
- Duración de la fuente audiovisual: 17:52
- Fuente original: WALK-TEC-01_Entrevista.mp4
- Estado: Transcripción pública anonimizada
- Marcas de tiempo: No estaban presentes en la transcripción fuente; no se añadieron tiempos estimados para no inventar evidencia.

Transcripción

ENTREVISTADOR: [SILENCIO] Ahí sí. Comenzamos con lo que es el consentimiento informado. Primero que nada, quería ver si estaba de acuerdo con lo que filmó previamente también. Y, por lo ahorita, recalcarlo, lo que es el consentimiento para la toma de imagen, el video, para todo lo que estamos realizando.

TEC-01: Sí estoy de acuerdo.

ENTREVISTADOR: Listo. Con todo esto, damos paso en lo que es la entrevista. Comenzamos con lo que es primero las preguntas en cuestión a lo que tenemos de la encuesta. Que es, vamos a revisar unas preguntas y quisiera que me contestes con lo que usted opina. Comenzamos. Primera pregunta que es, ¿qué limitaciones existe actualmente en el seguimiento y control de pacientes en terapias físicas?

TEC-01: Ya, con respecto a las limitaciones, muchas veces es-- Primero que todo es llevar la comunicación con el paciente porque muchas veces el paciente no nos cuenta bien cómo va avanzando en casa. Porque, claro, el trabajo se realiza aquí en terapia, pero también se envía en casa a cambiar un poco su rutina diaria, su estilo de vida. Entonces, muchas veces el paciente no se olvida de contarnos a veces ciertas cosas, como me dolió al hacer tal movimiento. Entonces, ahí se limita un poquito al realizar el seguimiento.

ENTREVISTADOR: Listo. Seguimos con la siguiente pregunta que es, ¿qué información del paciente considera importante conocer antes de iniciar una terapia física?

TEC-01: Es importante conocer la edad del paciente porque influye mucho en qué edad se encuentre para, según eso, saber cómo manejar el caso en específico, la edad y también las comorbilidades, es decir, enfermedades de base. Ya que no es lo mismo atender a un paciente que tiene hipertensión como un paciente que no lo tiene. En un paciente con hipertensión se debe tener un poco más de cuidado al momento de realizar los ejercicios. Y siempre antes de iniciar la terapia, tomar la presión, a ver si se puede trabajar o tal vez ese día cancelamos la terapia debido a que se encuentra con la presión alta.

ENTREVISTADOR: Listo. Vamos con la siguiente que es, ¿qué información terapéutica considera importante registrar durante el tratamiento del paciente?

TEC-01: OK. Lo que yo siempre registro y me parece muy importante es el dolor del paciente. Por lo general utilizamos la escala de Eva, la escala de dolor de Eva. Entonces, en esa escala podemos preguntarle al paciente, ¿del 0 al 10 qué tanto dolor tiene? Entonces, siempre hay

que vigilar que el paciente al realizar el ejercicio o la técnica que estemos utilizando, no vaya a tener un dolor mayor a 5. Entonces, esta escala es importante. Además, si se trata de fortalecimiento, también la escala de BOR, que es la escala de esfuerzo percibido para saber qué tanto cansancio o fatiga siente el paciente.

ENTREVISTADOR: Listo. Salimos con la siguiente que es, ¿qué tipo de seguimiento considera necesario para mejorar la recuperación del paciente?

TEC-01: Ya, a mí me parece que es muy importante un seguimiento diario. No es tan necesario que el paciente venga todos los días a terapia, pero sí es necesario saber todos los días cómo se sintió, si pudo dormir, si ese día se levantó con más dolor o con menos dolor, qué realizó, qué no realizó. Entonces, diariamente se debe tener conocimiento de cómo va avanzando el paciente y qué actividades le generan dolor o no.

ENTREVISTADOR: Listo. Después seguimos con la siguiente que es, ¿cómo realizan actualmente el seguimiento de pacientes que continúan ejercicios desde casa?

TEC-01: Lo que yo hago es, por lo general, siempre escribirlos, mandarlos un WhatsApp, preguntarles cómo se encuentran, qué tal le fue con los ejercicios. Porque adicional, por ejemplo, si es que es un paciente que puede venir una vez a la semana o dos veces a la semana, lo que yo hago es enviar un video para que el paciente se guía con este video de cómo debe realizar los ejercicios en casa. Entonces, yo le pregunto cómo le ha ido con los ejercicios. Más que todo, todo por mensaje. Aquí se complica un poco en la cuestión del adulto mayor que muchas veces no maneja el celular o las tecnologías.

ENTREVISTADOR: Listo. Seguimos con la siguiente pregunta que es, ¿qué dificultades presentan los pacientes en realizar terapias sin supervisión?

TEC-01: Bueno, aquí hay bastantes dificultades y enfocándolos nuevamente en el adulto mayor que es, por lo general, el paciente más recurrente en terapia física. Este paciente, si no tiene un seguimiento, si no hay una supervisión como tal, el paciente hace los ejercicios, pero los hace, digamos, de manera muy rápida o tal vez ni los hace. Y a terapia dice que sí. Entonces, es un poco complicado saber si lo realizó o si lo hace, pero lo hace bien. Porque no es de hacer el movimiento así porque sí, sino que tiene que haber un movimiento controlado, un movimiento lento y que no sea demasiado brusco. Entonces, es complicado. O sea, el paciente debería siempre tener una supervisión. A veces no tanto de estarlo viendo lo que realiza, pero sí que sea consciente de cómo debe hacer las cosas.

ENTREVISTADOR: Listo. Seguimos con la siguiente de esta sección, la última de esta sección, que es, ¿qué problemas existen actualmente para verificar si el paciente realiza correctamente los ejercicios?

TEC-01: Problemas porque en casa no podemos verificar realmente si los está haciendo bien o no. Simplemente nos queda como que aceptar la palabra del paciente si los hizo bien o no. Entonces, aquí no hay mucha objetividad, sino más bien es subjetivo.

ENTREVISTADOR: Listo. Seguimos con la siguiente sección que tenemos una pregunta principal, la cual es, ¿qué aspecto considera fundamental para garantizar una correcta recuperación del paciente?

TEC-01: Importante, el compromiso del fisio como profesional y el compromiso del paciente. Porque siempre se trabaja de la mano. Yo siempre le digo a mis pacientes, aquí se hace, digamos, un 40%. Pero lo que se hace en casa es lo que realmente importa más. Porque aquí nos vamos educando al paciente sobre sus cambios en el estilo de vida, sobre la forma en la

que debe moverse. Entonces, aquí influye mucho, lo más importante es el compromiso mutuo. Y, claro, las ganas de que recuperarse también influye mucho.

ENTREVISTADOR: Listo. Seguimos con la siguiente que es, ¿qué tipo de ejercicio prescribe con mayor frecuencia a sus pacientes?

TEC-01: Ya. Por lo general, en este caso, me gusta empezar con ejercicios isométricos, dependiendo, claro, de cada patología. Pero los ejercicios isométricos son ejercicios que no generan dolor y que más bien generan un poco de analgesia. Entonces, al inicio de una terapia, yo siempre empiezo con este tipo de ejercicios.

ENTREVISTADOR: ¿Por qué?

TEC-01: Porque no voy a ponerle al paciente a hacer demasiado ejercicio con resistencia o ejercicios excéntricos, isotónicos, porque el paciente va a salir corriendo y va a decir, no me duele demasiado. En cambio, con los isométricos, el paciente sabe que, o sea, vamos poco a poco, no va a ir algo demasiado cargado. Y, aparte, siente un poco de memoria.

ENTREVISTADOR: Listo. Seguimos con la siguiente que es, ¿qué ejercicio requiere mayor supervisión o control durante la terapia?

TEC-01: Todos los ejercicios son-- es importante supervisarlos. Pero cuando ya se empieza a trabajar con cargas, con peso, es importante, es mucho más importante aún. Porque a veces el paciente-- y me ha pasado que el paciente dice, no, es que yo me siento bien y te pone mucho peso o hace muchas repeticiones y acaba fatigando más el músculo y no hay una recuperación como tal.

ENTREVISTADOR: Listo. Seguimos con la siguiente que es, ¿qué ejercicios observa con mayor frecuencia cuando el paciente realiza-- Sí. Perdón, le repito, ¿qué errores observa con mayor frecuencia cuando el paciente realiza ejercicios terapéuticos?

TEC-01: Más observar por lo general es que el paciente muchas veces, por ejemplo, hablemos de una sentadilla. El paciente tiende a llevar las rodillas hacia adentro cuando